

INFORME PSICOLÓGICO INICIAL

Paciente: Jhoana Alejandra Márquez Romero.

Fecha de Nacimiento: 16 de enero de 1999.

Edad: 24 años (al momento de la evaluación).

Sexo: Femenino.

Estado civil: Soltera.

Profesión: Médico.

Lugar de procedencia: Valledupar- Colombia.

Lugar de residencia: Houston- Texas. (al inicio de la Evaluación).

TA: Psicología.

Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2023.

No de Sesiones: 5 sesiones de evaluación. Fechas: 26 de diciembre 2023, 19, 23, 30 de enero y 9 de febrero 2024.

Evaluable por: Diana Cecilia Gómez Miranda.

Motivo de consulta:

“Yo he tenido, así como terapias aisladas. Chiquita mi hermano menor falleció (yo tenía 9 años y él año y 10 meses). Estuve en psicólogo del colegio, por EPS, y ya adulta por mí, particular, a partir del año pasado”. “Yo soy más como activa, me gustaría más cómo saber, la parte de herramientas, todo eso si me llama la atención”.

*“Conocerme, quiero saber qué es lo que en realidad está pasando, **dependiendo de lo que salga necesito ayuda porque no puedo con tanto**”.*

Tratamiento anterior:

“En 2021 si la estaba pasando muy mal, inicialmente solicité psiquiatría, pero no fui”.

“Comencé a recolectar remisiones por psiquiatría”.

“Me sentí como estancada”. “Ella me ponía tareas, pero yo procrastino”.

“Yo feliz que me escuchen, pero si tenía como ese approach pasivo (terapia)”.

“Fui como a 10 sesiones, pero a lo largo de un año”.

“Me gusta un proceso más organizado”.

“Es que, si a mí me dejan así al aire, no funciona”.

“Tengo depresión y ansiedad (Trastorno Mixto)”.

Datos significativos de Historia personal (principales recuerdos de la paciente):

- Violencia Intrafamiliar (maltrato verbal y físico).
- Problemática de adicciones núcleo familiar (hermano drogas, padres alcohol).
- Fallecimiento hermanito (tenía un año y diez meses).
- Relación disfuncional madre- padre- hermano.

Se presume que existe otro evento que aún no ha sido expresado.

Antecedentes médicos/medicamentos actuales:

N/R.

Quejas (manifestaciones) de la paciente:

A nivel cognitivo:

“Mi relación con mi familia es muy fuerte”. “Es que yo tengo muy mala relación con mi familia. Violencia”.

“Yo soy como la fuerte, pero llega un punto en que afecta”.

“En las relaciones veo los mismos patrones y la codependencia (de mi parte)”.

“Siempre he sido así como muy independiente”.

“Con los tres tengo una relación disfuncional (mamá, papá, hermano)”.

“Es como si estuvieran los tres contra mí. Al final todos van contra mí”.

“Siento que para mis papás en general, siento que lo que yo soy y hago no es suficiente”.

“Soy como la oveja negra, y ¡A ver soy médico!”.

“Ella tiene preferencia por mi hermano. Ella (mamá), dice que es que mi hermano ha tenido más problemas y eso, y puede que sí”.

“Ella (mamá) es muy difícil de manejar”.

“Todo es una pelea”.

“Ella lo escucha mal y se formó”.

“Mi hermano empezó a consumir marihuana y generó una dependencia tenaz”.

“Yo intenté llevármelo para Bucaramanga”.

“Él tiene mucho resentimiento hacía mí porque él piensa que yo soy exitosa, y él no”.

“Él (hermano) es muy patán, grosero, y luego la arrogante soy yo”.

“Mi mamá comparaciones entre él y yo”.

“Él tiene conductas desastrosas y mis papás le resuelven todo enseguida, y conmigo es, es que tú tienes que ser agradecida”.

“Me dieron la carrera”.

“Mis papás se lo creyeron como siempre (hermano-adicción)”.

“Él es grosero y siempre lo ha sido conmigo”.

“De mi vida personal mi familia no sabe nada”.

“Aquí ha sido pelea tras pelea”.

“Yo replico cosas de ellos (padres) en mis relaciones”.

“Mi mamá me hacía llamarlo que no teníamos comida (al papá)”.

“Yo era Jhoana la fuerte y me lo creí”.

“El 14 de octubre tuve un accidente que casi me muero, el carro quedó vuelto nada y fue, -me dañaste el carro- “, “¿El carro o la hija?”.

“De pequeños nos pegaban bastante”.

“Mi papá le ha pegado mucho a mi mamá”.

“Mi mamá también (le pega al papá)”.

“Él era la luz de la casa (hermanito que falleció)”.

“A mí no me gustan los animales. No me gustan para nada”.

“Yo pasé por un montón de colegios (10/ 12), porque nos mudábamos muchísimo”.

“En segundo a mi mamá se le ocurrió la idea de volarme un curso, hice examen en otro colegio y pasé a cuarto”. “Era la más chiquita en estatura y la menor”.

“Yo soy muy introvertida entonces no sobresalía en la parte social”.

“Pienso que eso es un problema para mí (la parte social)”.

“Independientemente las personas extrovertidas tienden a ser más inteligentes, a tener más éxito. La vida es de relaciones”.

“Mi círculo es bastante cerrado”.

“Yo no soy mucho de llorar, es como rabia siempre, molestia”.

“No me matriculó a tiempo, me quedé sin cupo porque para 10° y 11° ya reducían la cantidad”. “Ella es muy descuidada (mamá)”.

“Soy distintas personas dependiendo de con quién me relacione, del nivel de confianza, y me cuesta mucho ser completamente yo, siento que voy a ser juzgada”.

“Mi familia toma mucho”.

“Familiar con problemas de alcohol. Soy muy propensa”.

“Tengo periodos cortos en donde intento y no logro parar (alcohol)”.

“No ha afectado la parte laboral (alcohol)”.

“Tuve un tiempo de consumo experimental (marihuana- sensación de novedad). Hubo un tiempo frecuente. (Cuando volví ya no fue muy frecuente, o sea cuando lo retomé después de varios años, en su tiempo si me gustaba la sensación)”.

“En 2021 tuve una ruptura y los problemas familiares al mismo tiempo (alcohol)”.

*“Salía mucho, tenía **lagunas mentales**”.*

“Me preocupa cómo voy a organizarme con mi dinero, para la especialidad, etc.”.

“Quiero tomar este año mejores decisiones que el año pasado”.

“A mí me gusta mucho planear, yo planeo, y planeo, y planeo, y de las cosas que planeo, el 80% no sale”.

“En escenarios de compararme con otras personas, en esta carrera es fácil pensarlo (inferior)”.

“En mi mente ya sabía que iba a ir a estresarme”.

“A mí como que siempre me han invalidado”.

“Soy la fuerte, mi hermano el débil, yo casi no lloro”.

“Me involucraba siempre en discusiones (mamá)”.

“Mi mamá es volátil, pero cuando no, es súper cariñosa, al punto que se ve falso”.

“Mi papá es grosero”.

“He vivido mucha violencia verbal y física”.

“Yo a veces siento que ella es como una peladita (mamá)”.

“En situaciones de pelea (violencia), me tocaba intervenir (muy violentos)”.

“Vivía y vivo con ese miedo, porque son muy violentos”.

“Mi papá solo tiene dos planes, TV y tomar”.

“Toda mi familia (materna) es muy tomadora, con la de mi papá casi no trato con ellos”.

“Siempre ha sido así (violencia)”.

“Peleas muchas. Si hay algo que replico en mis relaciones son las peleas. Si han escalado, pero no a golpes”.

“Es una sensación de ira incontrolable”.

“Creo que soy hiriente, me aprieto mucho las manos, con las uñas me lastimo las manos. Me he dado bofetadas, pero no es frecuente (como en 5 ocasiones)”.

“Siento como si me quemara por dentro (ira)”.

“A mí me da miedo porque mis papás son muy violentos. ¿Qué tal que yo sea capaz de lastimar a alguien?”.

Afectivo/ Emocional:

Ira, rabia, ansiedad, preocupación, tristeza, vergüenza, irritabilidad, frustración, impotencia, ambivalencia, miedo.

Conductual:

Autolesiones, Conducta inasertiva (*pasiva/agresiva- discusiones, confrontación, “peleas”*), evitación- escape (alcohol).

Fisiológico:

Sensación de “quemarse por dentro”, palpitaciones, sudoración, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor en el pecho, náuseas.

Relacional:

Padre, madre, hermano.

Contextual:

Intrafamiliar e Interpersonal en general (incluyendo parejas).

Análisis resultados:

Paciente auto referida, en su descripción general, no presenta ningún aspecto curioso o llamativo. Su conducta está de acuerdo al contexto de la entrevista, mantiene la conversación sin dificultad y puede referir con claridad lo que piensa y siente, aunque prefiere que su relato sea direccionado con preguntas específicas y da a entender que se reserva cierta información. Su actitud es de interés, aunque distante. Presenta estado óptimo de consciencia, adecuada orientación auto y alopsíquica; no presenta dificultad en sensopercepción, ni en estructuración de pensamiento, juicio, ni raciocinio, etc.

Las dificultades de la paciente se centran básicamente en el procesamiento de la información, en el que predominan distorsiones cognitivas como:

Pensamiento polarizado o dicotómico (*-todo o nada-* ser extremista, ver las cosas como blanco/negro, sin considerar la existencia de categorías intermedias), **Conclusión precipitada o Inferencia arbitraria** de ambos tipos (*Lectura de pensamiento o pensar mal y Anticipación negativa o error del adivino*), **Abstracción selectiva o filtro mental** (*visión de túnel*), Deberías, Personalización, Sobregeneralización, entre otras.

De acuerdo con los resultados de la prueba EMT (Esquemas Maladaptativos tempranos), la paciente presenta **alteración en 9 de los 15 esquemas que evalúa la prueba**. En el **ÁREA AUTONOMIA**, se evidencian dificultades en el esquema de: Sometimiento/Falta de individualidad, Miedo a perder el control, en el **ÁREA DE CONEXIÓN**, en los esquemas de: Carencias emocionales, Abandono/Pérdida; Falta de confianza, en el **ÁREA VALOR DE SÍ MISMO**, se encuentran dificultades en los esquemas de: Defectuosidad/ Incapacidad de ser amado, Incompetencia/Fracaso, Vergüenza/Turbación, y en el **ÁREA DE LÍMITES**, en el esquema correspondiente a: **Límites insuficientes**.

Los esquemas con mayor alteración son en su orden: **CARENCIAS EMOCIONALES, SOMETIMIENTO/FALTA DE INDIVIDUALIDAD, ABANDONO/PÉRDIDA, DEFECTUOSIDAD/INCAPACIDAD DE SER AMADO.**

En el esquema de **CARENCIAS EMOCIONALES**, la frase que resume esta creencia es «*Mis necesidades no serán satisfechas*». Este esquema se desarrolla en la infancia cuando uno o ambos padres están tan ocupados —ya sea con su trabajo, sus propios conflictos, con algún problema psicológico o alguna preocupación constante— que sencillamente no perciben o no se preocupan por las reales necesidades emocionales de su hijo (a). Los pacientes que presentan este esquema por lo general indican “*Recuerdo mi afán de hacerme invisible de pequeño, de ser la niña (o) que no diera problemas*”. Ese querer estar donde no se es visto, encerrarse, ocultarse, experimentando el alivio de no ser un problema para esos padres, junto a la angustia de no ser tenido realmente en cuenta por una o ambas figuras vinculares.

El **esquema de carencia** vuelve a estos pacientes hipersensibles a los signos de que no se les toma en consideración, particularmente en el seno de las relaciones más próximas. Las personas con este esquema pueden sentirse irascibles cuando sus necesidades son ignoradas. Esa **ira**, a su vez, esconde un sentimiento subyacente de **soledad y tristeza**.

Se suele distorsionar la realidad interpretando como que se está siendo ignorado o que se les ve con pesar, con lástima, lo cual suele llevar a futuro a un “gran variedad de decepciones crónicas en las relaciones interpersonales”.

SOMETIMIENTO/FALTA DE INDIVIDUALIDAD: “Este esquema se suele originar en una infancia dominada por padre (s), demasiado controladores, que no dejan que el menor exprese sus necesidades. La afirmación de poder por parte de los padres va mucho más allá de los límites y reglas necesarias para la convivencia, llegando a ignorarse la necesidad de autonomía del menor. Así, el niño comprende muy pronto que sus sentimientos y necesidades no cuentan, y aprende a sentirse impotente y desamparado en cuanto a lo que desea o necesita (baja tolerancia a la frustración). “Un esquema que se origina en la infancia tras unos padres tan controladores, que no permiten que el niño exprese sus necesidades, de adultos les costará tomar decisiones o dejarán que otras personas tomen las decisiones afectivas por ellos. De adultos, esas personas puede que estén tan acostumbradas a que la otra persona los mande que ya no están en contacto con lo que realmente desean o necesitan, y aunque sientan que tienen control en realidad en el marco de las relaciones, este control lo ejerce la pareja (complacer a ser complacido)”.

Estrategias de supervivencia: Una de las estrategias que puede asumirse ante una actitud dominante en la infancia por parte de los padres, es la pasividad o la rendición, para no tener que enfrentarse a los signos de desaprobación. Siendo “una buena chica”, “la niña bueno”, “la que no da problemas”, “de alguna forma la niña modelo, que evita el conflicto o la confrontación”, así se asegura cierta paz en el hogar y en su vida.

Los pacientes que adoptan esta estrategia en el fondo están **deseosos de agradar**. “Pueden acabar siguiendo carreras elegidas por sus padres, o como se mencionó antes ser condescendiente a las exigencias de una pareja dominante o ceder muy rápido a los caprichos de los hijos; pero, por debajo de todo ello, está la rabia y el resentimiento, que se va acumulando en forma de cólera contenida, pero que les cuesta hacer consciente”.

En cuanto al esquema de ABANDONO/PÉRDIDA, en el núcleo de este esquema está en el temor a que las personas a las que se quiere se vayan a ir. Este patrón puede tener sus raíces en experiencias infantiles reales o simbólicas de abandono.

*La respuesta automática de un niño pequeño al miedo de que una persona clave en su vida lo abandone es, aferrarse más, o buscar constantemente la seguridad de que alguien va a estar; **ser dependiente ofrece un antídoto imaginado al temido abandono**. Pero eso estará fuera de lugar cuando, ya siendo adultos, el mismo temor salga a la superficie una y otra vez en las relaciones más íntimas. **Eso puede conducir a que la persona precise constante reafirmación de que la relación es estable y firme, y a veces puede conducir a que se cumpla el pronóstico temido, ahuyentando a la pareja. Otra reacción posible es que, por miedo a que la persona amada los abandone, ocultan***

sus temores y se someten a los deseos del otro, aunque no coincidan con los suyos. Por último, también se puede escapar de las relaciones antes de que la pareja sea quien deje, y/o no definir claramente el marco de la relación (aclarar el vínculo), lo cual es otra forma de eludir el abandono temido.

Los sentimientos que una separación temporal —o la pérdida real de una relación íntima— dispara en alguien con el esquema de abandono son mucho más fuertes de los que sentiría otra persona. La posibilidad misma de tal abandono puede disparar un pánico muy agudo.

Lo peor del sentimiento de abandono es que el paciente cree merecerlo (culpa). Todo el mundo tiene derecho a estar acompañado y ser querido menos él. El paciente piensa que hay algo en él que impide que la gente quiera estar a su lado, o solo durante periodos cortos, mientras resulte «divertido, interesante» y atienda a sus deseos.

Referente al esquema de **DEFECTUOSIDAD/ INCAPACIDAD DE SER AMADO**, La afirmación automática de este esquema (**DESVALORIZACIÓN**), es <<**No resultado interesante**>>. “Cuando me conozcan realmente se darán cuenta de que no soy interesante”. La emoción que acompaña a este pensamiento es la **vergüenza** y la **humillación**. En el centro de este esquema subyace la sensación de ser imperfecto; es decir, de que si alguien lo conoce como realmente es, encontrará defectos imperdonables”.

Así mismo, otro de los esquemas con puntaje significativo en la paciente, es el **ESQUEMA DE VERGÜENZA**, este implica también una **hipersensibilidad a la crítica, auto rechazo, culpa, comparaciones e inseguridad frente a los demás.** Un sentimiento de vergüenza relacionado con la percepción de imperfección, con situaciones de su historia y con el temor a quedar “expuesta” ante los ojos de todos, y su supuesto fracaso en todas las áreas de su vida. (“Síndrome del Impostor” /sensación de no estar a la altura).

En cuanto al esquema de **FALTA DE CONFIANZA**, este se evidencia en todo el proceso de Evaluación. La frase que tipifica la creencia de este **esquema** es «**No se puede confiar en la gente**». La emoción que surge con ese pensamiento es la rabia, la **cólera**. Las personas que sufren este patrón están constantemente en **alerta**, temiendo que la gente vaya a aprovecharse de ellas de algún modo o que las traicionen. En consecuencia, **les cuesta mucho acercarse o abrirse a los demás, la realidad es que no les gusta sentirse expuestos. No se sienten cómodos intimando, no le gusta que los perciban vulnerables,** aunque, paradójicamente, suelen juntarse precisamente con personas que confirman sus peores miedos, involucrándose en relaciones con gente que no les retribuye lo que ellos brindan.

La desconfianza, se relaciona con la respuesta positiva en la niñez a un miedo genuino. Este esquema se suele originar por haber **sufrido abuso,** haber sido de algún modo maltratado física, sexual o emocionalmente en los

primeros años de vida, y/o por desconexión, distancia con principales figuras vinculares, es decir, falta de cercanía, de expresión, manifestación de afecto y de relación de confianza con estos.

El **esquema de la desconfianza** difiere de la mayoría de los otros en que, en él, el padre, la madre o alguna de las personas más cercanas al niño, **es distante, poco afectuoso** o incluso puede ser intencionadamente hiriente o cruel. Dada una realidad tan terrible en la vida de un niño, **en el que sus emociones NO son validadas, la desconfianza puede ser una respuesta positiva a un miedo genuino: la gente significativa en la vida del menor no es fiable o no hay cercana relación. Los perciben distantes y/o no interesados en su estado emocional, y para sobrevivir, consideran que es necesario desarrollar un radar social.**

Cuando se ve la vida a través del lente deformante del esquema de la desconfianza, las relaciones pueden parecer un terreno peligroso, un lugar donde la gente alberga secretamente la intención de herir o de aprovecharse. Estas sospechas pueden llegar a hacer ver de forma distorsionada lo que la gente dice o hace, para detectar en ello lo que parece ser una traición. El paciente siente que ha de estar siempre alerta, atento, para defenderse de los demás.

Hay varias modalidades a las que puede conducir este esquema. En una de ellas, la persona ve a todo el mundo con una suspicacia tal que se aparta de cualquier relación fiable, nadie cumple sus estándares y/o con sus filtros para que pueda entrar fácilmente en su vida. En otros casos, al principio idealiza a la otra persona como si fuese protectora, pero luego reacciona ante cualquier aparente traición, volviéndose contra esa persona (*al inicio todo ok, pero ya luego si se siente traicionado, adiós para siempre*). Otra variación es la de quien se entrega a una serie de relaciones, cada una de las cuales repite situaciones de abuso (maltrato físico y/o emocional), es el desear estar con quien tampoco les demuestra ese vínculo emocional de esa cercanía y afecto”.

Al haber tenido de pequeña esta situación en casa, en el lugar donde el menor se esperaba que se hubiese sentido escuchado, validado, seguro, amado y protegido, se les hace muy difícil confiar realmente en los demás a lo largo de la vida. De hecho, una de las mayores dificultades es el *¿cómo distinguir entre aquellos que podrían hacer daño y los que no, si con lo que estaba familiarizado desde niño los hirió?*

Algo sumamente importante es que el cerebro humano, en estos casos, trata de reproducir de nuevo las mismas situaciones para, *“infructuosamente, darles un final feliz”*. A lo largo de la vida, es común que estos pacientes escojan parejas que no las traten de forma “adecuada” en algún sentido, y pueden tratar de

«reformularlas» para que las “traten bien”, lo cual resultaba inviable, o iniciar relaciones intentando “salvar al otro”, “ayudar”, “reformular”, “rehabilitarlo”.

Al no recibir intervención terapéutica, con los años la mayoría de los pacientes refuerza la creencia de que ha “estropeado el radar para detectar a las personas confiables”. Se preguntan, *¿cómo confiar en los demás? Y, lo primero, ¿cómo confiar en ti, en tu intuición? “Es como andar por un campo minado”.*

Otro esquema que se evidencia alterado en la prueba es el del **MIEDO A PERDER EL CONTROL**, en el caso de la paciente, es el temor por perder el control de sus propios pensamientos, conductas y/o impulso, sobre todo siendo consciente de las características violentas de su núcleo familiar primario. De hecho, la paciente abiertamente manifiesta: ***“A mí me da miedo porque mis papás son muy violentos. ¿Qué tal que yo sea capaz de lastimar a alguien?”.***

El cuanto al esquema de **INCOMPETENCIA/FRACASO**, este también es evidente en la paciente, este esquema se desarrolla en el dominio del trabajo, de los logros y de la profesión, y se puede confirmar con todas las verbalizaciones realizadas en la entrevista clínica. La afirmación que prevalece en este esquema es ***«No soy lo suficientemente buena para tener éxito».*** “Las emociones que lo acompañan son ***inseguridad, angustia y tristeza***. Se centra en la sensación de que los éxitos propios son innmerecidos, en que no es

posible triunfar realmente en nada por más que se intente, o que se tiene que esforzar el doble o el triple, para conseguir resultados que otros conseguirían con mucho menor esfuerzo.

Por último, referente al esquema de **LÍMITES INSUFICIENTES** (insuficiente autocontrol/disciplina), que también puntúa fuera del rango (*y es muy significativo en la paciente*), este se asocia con dificultades para disciplinarse, para colocarse LÍMITES en diferentes áreas, falta de disciplina en general, falta de “voluntad” para completar algunas rutinas o tareas, y en cuanto a límites emocionales (*dificultades para gestionar sus emociones*). Dificultad persistente o negativa a emplear el suficiente autocontrol (sexo, dinero, alcohol y/o droga), así mismo se relaciona con la poca tolerancia a la frustración (dificultad para decirse no, para parar, y/o para conseguir sus propios objetivos).

En todo lo anterior, se identifican **FACTORES ADQUISITIVOS** por condicionamiento clásico, operante, modelamiento y por construcción activa de esquemas, creencias e ideas, los cuales se revisan durante la intervención, específicamente durante la fase correspondiente a la psicoeducación del proceso de Reestructuración Cognitiva (primer objetivo terapéutico).

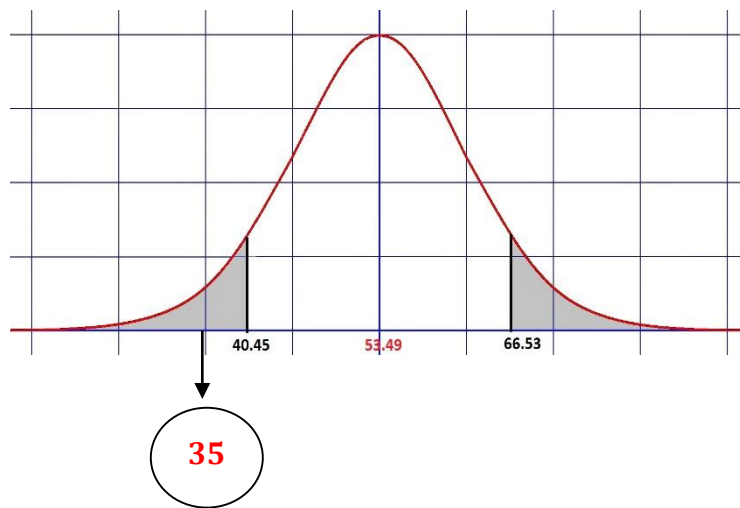
En cuanto al **Apego** en la paciente, es claro que no tuvo un apego un seguro. Se considera que su tipo de apego corresponde al apego desorganizado; no obstante, presenta características del apego evitativo.

- **Apego Inseguro- Evitativo:** *las figuras de apego se muestran hostiles o frías hacia las demandas afectivas del bebé porque las consideran excesivas e irracionales y rehúyen del contacto físico. Ven la emoción del menor como señal de debilidad, son figuras de apego muy estrictas. Estos niños aprenden a congelar sus emociones, a ser los “fuertes”, a reprimir sus necesidades, a no mostrarlas porque piensan que si lo hacen van a incomodar, a molestar o a dar problemas (lo hacen para no ser rechazados). Como adultos pueden establecer la creencia que necesitar algo de los demás les hace débiles, y tienden entonces a desarrollar comportamientos de tipo evitativo. Son personas que van y vienen de las relaciones, huyen, se les dificulta compartir su intimidad con otros.*
- **Apego Desorganizado:** *Es el tipo más grave. Son cuidadores crueles, violentos y en la relación con el menor prima el maltrato. Para estos niños su figura de apego que se supone es su “refugio”, es al mismo tiempo una amenaza. Como adultos, vemos muy probablemente dificultad para expresar emociones, dificultad para respetar sus derechos y los de los otros, así como para establecer y establecerse límites.*

Así mismo, en el proceso de evaluación, se evidencian dificultades en cuanto a:
AUTOCONCEPTO, AUTOIMAGEN y AUTOESTIMA.

En cuanto a la conducta asertiva, la paciente obtuvo un puntaje de 35, siendo la media 53,49, denotando un estilo de comunicación PASIVO-INHIBIDO; No obstante, a través de la entrevista clínica y en general con todo el proceso de evaluación es claro que si bien su estilo de comunicación efectivamente NO es asertivo, y tal vez en términos de relaciones de pareja sí tienda a esta pasividad, la conducta agresiva también está presente en las relaciones interpersonales de la paciente, especialmente en las relaciones intrafamiliares, en las que prima la violencia. Se considera clave para el alcance de resultados en la paciente, que pueda establecerse un objetivo puntual en este punto (Entrenamiento personalizado en Asertividad).

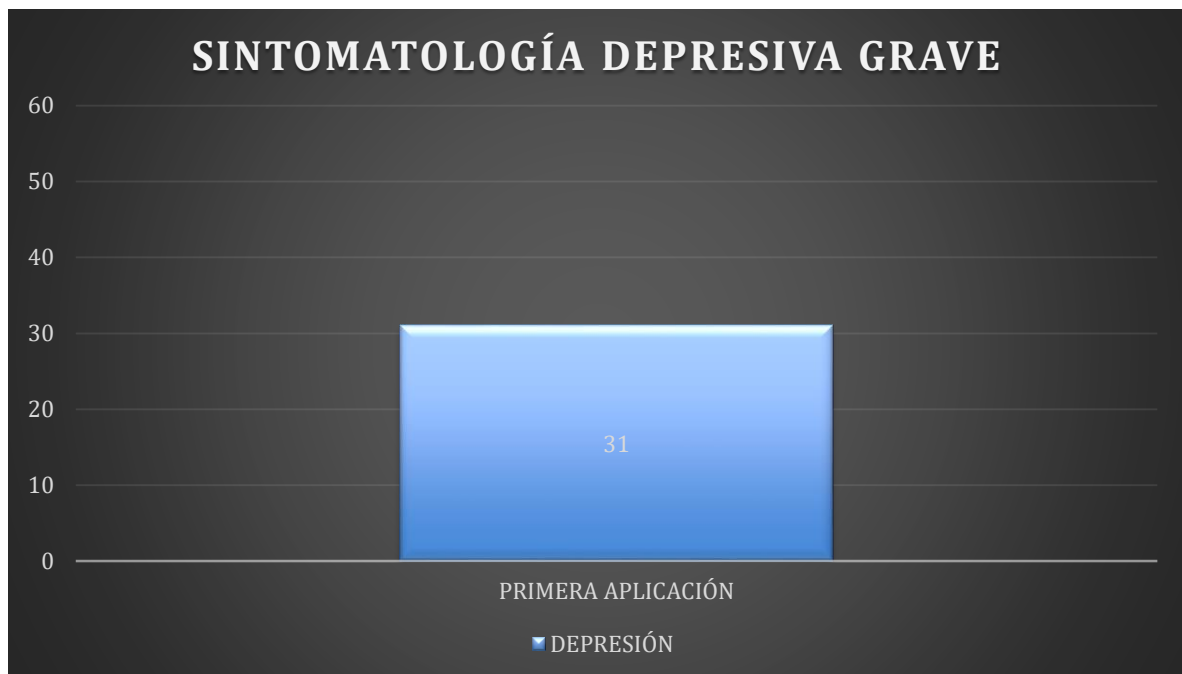
Resultado de Aplicación de Prueba psicotécnica, RATHUS MODIFICADO (Estilo de Comunicación PASIVO, INHIBIDO; ASERTIVO Y/O AGRESIVO).



Media= 53.49.

Puntuación de la paciente = 35, lo que indica un **Estilo de Comunicación PASIVO-INHIBIDO**.

Durante el proceso de evaluación también se evidencia que la paciente **presenta actualmente SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA**. Puntaje obtenido en INVENTARIO DE BECK (BDI-II): 31, **correspondiente a** sintomatología depresiva GRAVE.



Se destacan solo los siguientes resultados cualitativos en esta prueba:

“Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar”.

“Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo”.

“He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría”.

“Siento ganas de llorar, pero no puedo”.



“Estoy tan inquieta o agitada que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo algo”.

“He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas”.

“Tengo problemas para tomar cualquier decisión”.

“Me siento menos valioso cuando me comparo con otros”.

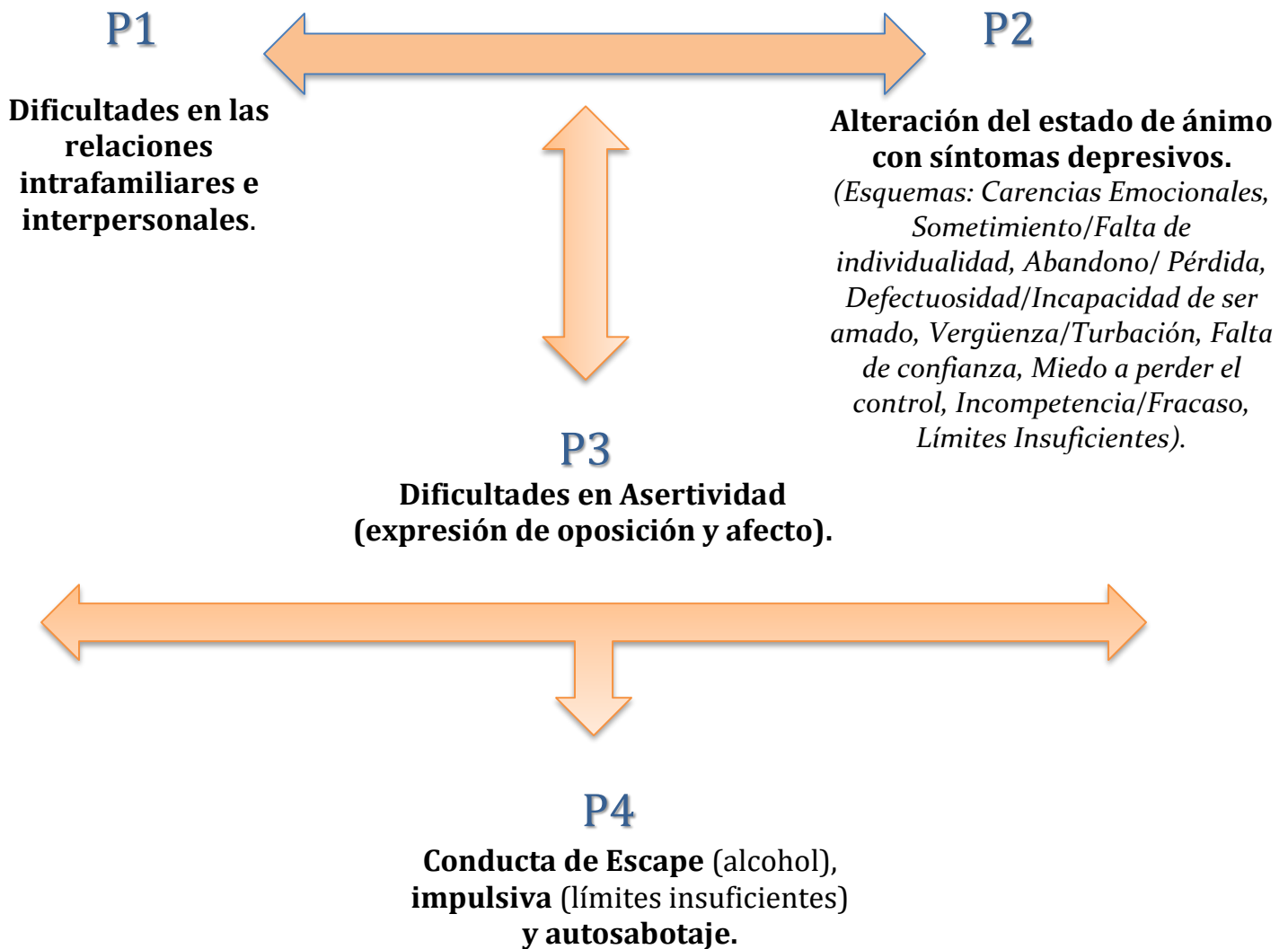
“No tengo suficiente energía para hacer demasiado”.

“Estoy mucho más irritable que lo habitual”.

“Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo”.

“Estoy demasiado cansada o fatigada para hacer muchas de las cosas que solía hacer”.

Problemas identificados: Análisis Molar: Hipótesis



- La relación molar es de tipo combinada.



Proceso de Evaluación.

ÁREA EVALUADA	PRUEBA	RESULTADO CUALITATIVO	RESULTADO CUANTITATIVO
COGNITIVA.	Cuestionario EMT. (Esquemas Maladaptativos Tempranos de Young).	Los Dominios y esquemas con puntuaciones significativas (por encima de lo esperado), son: Autonomía: Sometimiento- Falta de individualidad. Miedo a perder el control.	ÁREA AUTONOMÍA: Dependencia: Límites: 7,24 – 16, 14. Puntuación de la paciente: 16. <u>Sometimiento- Falta de individualidad: Límites: 21,54 – 43,58. Puntuación de la paciente: 62.</u> Vulnerabilidad al daño: Límites: 18,82 – 40, 14. Puntuación de la paciente: 20. <u>Miedo a perder el control: Límites: 10,04 – 24,02. Puntuación de la paciente: 27.</u>

		Conexión: Carencias Emocionales. Abandono/Pérdida. Falta de confianza.	ÁREA CONEXIÓN: <u>Carencias Emocionales: Límites: 6,11 – 21,75.</u> <u>Puntuación de la paciente: 40.</u> <u>Abandono/Pérdida: Límites: 9,21- 20, 59.</u> <u>Puntuación de la paciente: 28.</u> <u>Falta de confianza: Límites: 10, 39- 25, 05.</u> <u>Puntuación de la paciente: 31.</u> Aislamiento Social/ Alienación: Límites: 4,43 – 13, 71. Puntuación del paciente: 13.
		Valor de sí mismo: Defectuosidad/Incapacidad de ser amado. Incompetencia /Fracaso. Vergüenza/Turbación.	ÁREA VALOR DE SÍ MISMO: <u>Defectuosidad/ Incapacidad de ser amado:</u> <u>Límites: 3,75- 10, 59. Puntuación de la paciente:</u> <u>17.</u> Aceptación Social. Límites: 6,2 – 17,08. Puntuación de la paciente: 17.



		Límites: Límites Insuficientes.	<u>Incompetencia/ Fracaso: Límites: 6,81- 16,81.</u> <u>Puntuación de la paciente: 19.</u> Culpa/ Castigo: Límites: 9,69 – 19, 75. Puntuación de la paciente: 19. <u>Vergüenza/ Turbación: Límites: 3,79 – 12,01.</u> <u>Puntuación de la paciente: 19.</u> ÁREA LÍMITES: Estándares Inflexibles: Límites: 24,12 – 46,34. Puntuación de la paciente: 40. <u>Límites insuficientes: Límites: 12,56 – 28,74.</u> <u>Puntuación del paciente: 31.</u>
	Autorregistros.	Por medio de la entrevista clínica se evidencian las siguientes distorsiones cognitivas: -Falacia de razón. -Pensamiento polarizado, dicotómico, o todo o nada. -Abstracción selectiva, filtro mental, Visión de	ANEXO. AUTORREGISTROS. (<i>Durante la intervención se reforzará la importancia de diligenciarlos y enviar previo a cada sesión, para poder realizar de manera óptima el proceso de reestructuración</i>).



		túnel. -Descalificación de lo positivo. -Conclusión precipitada del tipo lectura de pensamiento o pensar mal. -Magnificación. - Deberías. -Etiquetación. -Personalización. -Comparación falsa.	
	Cuestionario de Autoesquemas (CIE).	Dificultades en AUTOCONCEPTO, AUTOIMAGEN y AUTOESTIMA.	Autoconcepto: Promedio entre 55,2 y 79,8. Media: 67,5. Puntaje de la paciente: 46. Autoimagen: Promedio entre 35,89 y 50,29. Media: 43,09. Puntaje de la paciente: 30. Autoestima: Promedio entre 53,1 y 77,9.

			Media: 65,5. Puntaje de la paciente: 48.
AFECTIVA/ EMOCIONAL	Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)	Síntomas depresivos GRAVES.	Las puntuaciones mínima y máxima en la prueba son 0 y 63. Se han establecido puntos de corte que permiten clasificar a los evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima depresión; 14-19, depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 29-63, depresión grave. Puntaje del paciente: 31.
CONDUCTUAL	Escala de Asertividad de Rathus.	Estilo de comunicación: PASIVO-INHIBIDO.	Límite inferior: 40,45. Media: 53,49. Límite superior: 66,53. Puntaje de la paciente: 35.
RELACIONAL	F. N. E. Escala de miedo a la evaluación negativa.	Se evidencia tensión en situaciones de evaluación social. <u>Se registra ALTO temor a la evaluación negativa.</u>	BAREMOS: MEDIA 13 DESV. MIN 8 DESV. MAX 18 Puntaje de la paciente: 20.

	Escala de Evitación y Malestar Social (S.A.D)	Los resultados de la prueba no <u>indican presencia de EVITACIÓN, ni de MALESTAR SOCIAL (ANSIEDAD).</u> No se evidencia malestar subjetivo en situaciones sociales, ni evitación activa o deseo de evitación.	Media: 9. D. Mínima: 4. D. Máxima: 14. Puntaje obtenido: 14.
	IPDE.	Trastorno Límite de la personalidad.	7 pts.
DSM 5.	Se revisa DSM 5, especialmente todo lo correspondiente al apartado de: -TRASTORNOS DEPRESIVOS, TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, TRASTORNOS ADICTIVOS. -OTROS PROBLEMAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCIÓN CLÍNICA.		



Impresión diagnóstica:

300.01 (F41.0) TRASTORNO DE PÁNICO.

296.32 (F33.1) TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR, EPISODIO RECURRENTE, MODERADO, CON ANSIEDAD: MODERADO-SEVERO. *

301.83 (F60.3) TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD LÍMITE.

V61.8 (Z63.8) NIVEL ELEVADO DE EMOCIÓN EXPRESADA EN LA FAMILIA.

OBJETIVOS:

- Favorecer bienestar emocional de la paciente, a través de un proceso completo de Reestructuración Cognitiva, que permita la construcción de pensamientos alternativos ante todos los 9 EMTs identificados (*Carencias Emocionales, Sometimiento/Falta de individualidad, Abandono/ Pérdida, Defectuosidad/Incapacidad de ser amado, Vergüenza/Turbación, Falta de confianza, Miedo a perder el control, Incompetencia/Fracaso, Límites Insuficientes*).
- Brindar herramientas de autorregulación para gestionar mejor ataques de pánico.
- Abordaje en Estrategias de afrontamiento con el fin de incrementar **tolerancia a la frustración y disminuir conductas de ansiedad, “agresivas” y/o impulsivas en situaciones puntuales actuales** (*las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos de una persona, Lazarus & Folkman, 1987*).

- Resignificar creencias asociadas a situaciones intrafamiliares e interpersonales de su historia personal, favoreciendo una nueva perspectiva para verlas, contribuyendo así al PERDÓN (en caso que así la paciente lo decida), y al AUTO PERDÓN.
- Propiciar la resignificación de experiencias traumáticas en su historia personal, asociadas a violencia intrafamiliar.
- Realizar Entrenamiento personalizado en ASERTIVIDAD (*Expresión de oposición y de afecto*), con el fin de favorecer el establecimiento de LÍMITES, y la comunicación en sus relaciones intrafamiliares e interpersonales en general.
- Orientar, psicoeducar y acompañar en todo lo relacionado a la gestión de sus emociones (*reaprendizaje emocional/ expresión real desde la emoción genuina*).
- Fortalecer AUTOESTIMA (*autoconcepto, autoeficacia, autoimagen y autorrefuerzo*).
- Orientar, psicoeducar, en todo lo relacionado a RELACIONES DE PAREJA, especialmente en cuanto a las características principales de una relación sana vs una relación “tóxica”, codependencia, tipos de apego y en cuanto a los MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO.

- Programa clínico TMV (tú mejor versión), en pro de construcción y deconstrucción de proyecto de vida (general), potenciando habilidades de eficacia personal (tus talentos).

RECOMENDACIONES:

- ☞ Adherencia al tratamiento. **Psicología Clínica**, mínimo 1 vez por semana, control por **Psiquiatría** (*de acuerdo con lo que determine el especialista*). Es muy importante que el tratamiento se pueda realizar de manera integral para poder ver resultados en el mediano y largo plazo.
- ☞ Una vez se inicie el proceso terapéutico clínico prioritario, es muy importante la continuidad en las sesiones (una vez por semana sin falta). Sesiones espaciadas interferirían notablemente con el cumplimiento de los objetivos, motivación y enganche con el proceso.
- ☞ Espacio de 30 minutos a la semana solo para ti. Ejemplo, Domingo. (*programar horario con actividades de autocuidado/ hobbies, cantar, pintar, tocar algún instrumento musical, etc.*). Explorar nuevos talentos.
- ☞ Registro de pensamientos, por lo menos uno por semana. (*esto es muy importante desde la intervención en este modelo*).

- ☎ Autoevaluación de límites (*entenderlos como esas líneas que no vamos, ni van a cruzar los otros, es decir, esas fronteras que nos mantienen a salvo, y nos ayudan a mantener relaciones desde el equilibrio*).
- ☎ Realizar de manera diaria Ejercicios de atención plena, para centrarte en el presente (*bajarles así a las lecturas de pensamiento*), y realizar por lo menos una vez a la semana una práctica de atención plena que además implique exteriores (*bajar el ritmo y tolerar la frustración al hacerlo*). Estos ejercicios se explicarán en la terapia y se dejarán como tareas terapéuticas.
- ☎ Mantener hábitos saludables (alimentación, deporte). Mantener actividad física. Rutina diaria.
- ☎ Practicar e incorporar a la rutina técnicas de respiración consciente y relajación que se expliquen en la intervención.
- ☎ Convertir Journaling (diario personal), en un hábito.
- ☎ Autoevaluación de todos tus “deberías” hacia ti misma, hacia el mundo y hacia los demás.
- ☎ Establecer cuadro de mini retos.

Observación: *el presente informe es absolutamente confidencial, está amparado en la reserva de historia clínica, es de uso exclusivo en la relación paciente- terapeuta, y se realiza de manera muy descriptiva, para facilitar la posterior reestructuración de pensamientos desde la TCC.*

***Para validar este informe como evidencia concluyente, se debe tener en cuenta las impresiones diagnósticas emitidas por el equipo interdisciplinar de atención que se solicita.**